

DEMARCHE DE SOINS / PENSEE CRITIQUE

Licence 2 Infirmiers(ères) Sages-femmes/Maïeuticiens

EDITION 2026

SOMMAIRE

POURQUOI UTILISE- T-ON LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE EN SOINS INFIRMIERS ?	4
DEMARCHE SCIENTIFIQUE DE SOINS INFIRMIERS	5
ETUDE DE CAS N°1 : Profil d'un client à partir du cadre de référence de Virginia Henderson.....	5
ETUDE DE CAS N°2 TRAVAUX DIRIGES :	
Recueil des données.....	10
ETUDE DE CAS N°3 : Profil d'un client à partir du cadre de référence de Virginia Henderson.....	18
EXERCICES.....	26
PENSEE CRITIQUE.....	27
Objectifs.....	28
Définitions.....	28
Généralités.....	29
Importance de la pensée critique.....	29
Éléments clés de la pensée critique	30
Application de la pensée critique.....	30
Étude de cas 1.....	31
Étude de cas 2.....	31
REFERENCES.....	32

DEMARCHE SCIENTIFIQUE EN SOINS INFIRMIERS

POURQUOI UTILISE- T-ON LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE EN SOINS INFIRMIERS ?

On peut se demander pour quelles raisons on utilise la démarche scientifique en soins infirmiers. En fait, sans ce processus, chaque infirmier(e) ou sage-femme doit agir à sa façon et selon son intuition. Il (elle) s'en remet en somme à la méthode des essais et des erreurs pour dispenser des soins et tenter de les améliorer.

Les interventions se trouvent donc fragmentées et sans continuité d'un(e) infirmier(e) ou d'une sage-femme à un(e) autre. Il devient alors difficile de les coordonner et de les évaluer. La démarche scientifique permet à cet effet de corriger ces difficultés. De plus, en mettant à la disposition de l'ensemble de l'équipe soignante les détails de la planification des soins, ce processus comporte plusieurs avantages au plan organisationnel. Il apporte d'abord au travail des utilisateurs une meilleure **continuité**. L'interrogatoire qu'il suscite au sujet des problèmes du client et de la réponse à y apporter, en font un instrument de rationalisation des soins. Il rend aussi possible une **coordination** plus efficace des diverses interventions de l'équipe soignante plus efficace dans diverses interventions de l'équipe soignante et l'**établissement des priorités** dans l'élaboration des soins.

Mais son plus grand avantage est sans doute lié au fait que la démarche repose sur des données fournies par le client lui-même ou prises à d'autres sources sûres. Ces données permettent de voir la situation dans son ensemble et d'apprécier les besoins réels de chaque sujet considéré comme une personne différente et unique en soi. La démarche de soins constitue donc un instrument d'**individualisation** et de **personnalisation** des soins. Elle concourt ainsi à leur humanisation.

Une autre qualité non négligeable de la démarche réside dans le fait que les informations qu'elle permet de fournir constituent un dossier évaluable. Cela fait une ressource forte utile pour le **développement de nouvelles approches de soins**, et même pour **l'évolution du personnel infirmier ou sage-femme**.

L'évaluation des soins est un mode de fonctionnement professionnel qui assure le contrôle de la qualité. L'utilité de la démarche scientifique du point de vue de l'organisation et de la qualité des soins n'est plus à démontrer. Son application fait d'ailleurs l'objet de normes de compétence régissant l'exercice infirmier.

DEMARCHE SCIENTIFIQUE EN SOINS INFIRMIERS

ETUDE DE CAS N°1

Profil d'un client à partir du cadre de référence de Virginia Henderson

1-Collecte de données

- **Renseignements généraux**

Nom et Prénoms : KOUDOUNGNON Mireille

Age : 21 ans

Sexe : Féminin

Situation matrimoniale : Célibataire

Profession : Etudiante

Diagnostic médical : Ulcère gastroduodénal

Régime : Hospitalisé au CHU

Traitement :

- Tagamet 800 : 1 comprimé le soir
- Mucal : 1 sachet 3 fois par jour
- Librax : 1 comprimé 3 fois par jour
- Clamoxyl 500 : 2 gélules 2 fois par jour

- **Besoins fondamentaux**

1-Respirer

-Rythme respiratoire : 16 mvts/mn

2-Boire et manger

-Aime manger à la sauce pimentée

-Prends habituellement 2 verres de vin à table

-Éprouve du dégoût pour le régime alimentaire prescrit (sans piment, ni alcool)

-Appétit pas bon

-Ne fume pas (tabac)

-En cas de fortes émotions, ne mange presque pas

3-Éliminer : élimine correctement (urines, selles)

4-Se mouvoir et se maintenir en bonne posture

-En cas de douleurs épigastriques, recherche une position antalgique

-Pas d'atteinte de l'intégrité de la peau

-Pouls : 92 ; TA : 120/70

5-Dormir et se reposer

- Habituellement dort 7 heures par nuit
- Sommeil troublé ce jour à cause des douleurs

6-Se vêtir et se dévêtir

- Aime être bien habillée
- Tenue du jour : pyjama bien soigné

7-Maintenir la température dans les limites de la normale :

- T°=37

8-Être propre soigné et protéger ses téguments

- Peau et téguments propres
- Draps propres et biens dressés

9-Éviter les dangers

- Stressée et anxieuse pour ses douleurs
- prend ses médicaments, mais pas toujours dans les horaires prescrits

10-Communiquer avec ses semblables

- Intégrité des organes de sens
- Voix audible, parle peu, mais répond aux questions
- Coopérante et non agressive
- Exprime ses émotions

11-Agir selon ses croyances et ses valeurs

- Croit en Dieu et est de religion chrétienne
- Prie tous les matins et le soir au coucher

12-S'occuper en vue de se réaliser

- Exprime le désir de sortir de l'hôpital en vue de prendre part aux examens universitaires, ce qui la rend quelque fois anxieuse
- Parle de ses projets : son rêve, devenir avocate

13-Se recréer

- S'adonne à la lecture
- Sa passion : la pratique du hand-ball

14-Apprendre

- Veut avoir davantage d'informations sur sa maladie
- Niveau scolaire : universitaire (étudiante en maîtrise de Droit)

2- Analyse et interprétation des données

2-1 Classification des données

Données d'indépendance	Données de dépendance
-Identité du client -Rythme respiratoire : 16 mvts/mn -Aime manger à la sauce pimentée -Prends 2 verres de vin à table -Ne fume pas (tabac) -Élimine correctement (urines, selles) -Recherche une position antalgique -Pas d'atteinte de l'intégrité de la peau -TA : 120/70 -Pouls : 92 ; -Dort 7 heures par nuit -Aime être bien habillée -Tenue du jour : pyjama bien soigné -Prend ses médicaments -Intégrité des organes de sens -Voix audible, parle peu, mais répond aux questions -Coopérante et non agressive -Croit en Dieu -Prie tous les matins et soir -Exprime le désir de sortir de l'hôpital -Parle de ses projets ... -S'adonne à la lecture -Sa passion : la pratique du hand-ball -Veut avoir davantage d'informations sur sa maladie -Étudiante en maîtrise de droit	-Ulcère gastroduodéal -Hospitalisation -Traitement (médicaments prescrits) -Dégoût pour le régime alimentaire -Appétit pas bon -Fortes émotions -Douleurs épigastriques -Trouble du sommeil -Stress, anxiété -Non-respect des horaires de prise de médicaments -Impossibilité de prendre part à ses examens

2-2 Détermination des problèmes de dépendance et des sources de difficultés

Manifestations de dépendance	Sources de difficultés
-Douleurs épigastrique	Ulcère gastroduodéal (physique)
-Troubles du sommeil	
-Stress	
-Appétit pas bon	-Dégoût pour son régime alimentaire (psychologique) -Fortes émotions (psychologique)
-Non-respect des horaires de prise des médicaments	-Manque de volonté ou de connaissance probable
-Impossibilité de prendre part à ses examens -Anxiété	-Hospitalisation (psychologique)
- Possibilité de troubles digestifs	- Clamoxyl

2-3 Diagnostics infirmiers

- Douleurs épigastriques et stress relié à l'UGD se manifestant par les troubles du sommeil
- Difficultés à s'alimenter reliées au dégoût pour son régime alimentaire aggravées par les fortes émotions
- Non-respect possible de son régime thérapeutique dû probablement à un manque de volonté et/ou de connaissance
- Incapacité d'assurer son rôle social relié à son hospitalisation se manifestant par l'anxiété.
- Possibilité de troubles digestifs reliés à l'administration du Clamoxyl (Amoxicilline)

2-4 Classification des diagnostics infirmiers

1-Diagnostic infirmier en rapport avec la maladie

- Douleurs épigastriques et stress relié à l'UGD se manifestant par les troubles du sommeil

2-Diagnostic en rapport avec le traitement

-Possibilité de troubles digestifs reliés à l'administration du Clamoxyl.

3-Diagnostic en rapport avec la personne malade

-Incapacité d'assurer son rôle social relié à l'hospitalisation se manifestant par l'anxiété.

-Difficultés à s'alimenter à cause du dégoût pour son régime alimentaire aggravé par les fortes émotions.

-Non-respect de son régime thérapeutique dû probablement à un manque de volonté.

Il ressort de ces diagnostics les besoins fondamentaux non satisfaits selon le modèle conceptuel de Virginia Henderson :

- Dormir et se reposer
- Éviter les dangers
- S'occuper en vue de se réaliser
- Manger et boire
- Apprendre

Ces diagnostics infirmiers et l'identification des besoins non satisfaits terminent l'étape de l'analyse et l'interprétation des données. On passe ensuite aux étapes suivantes à savoir, la planification, l'exécution et l'évaluation de l'intervention, cela à travers un plan de soins.

PLAN DE SOINS

LOGO DE LA STRUCTURE	NOMKOUDOUNGNON..... PRENOMSMireille ... SEXE : /_F___/ AGE : /_21 ans___/ PROVENANCE ...Cocody..... SERVICE N°CH : /_5___/ N° LIT : /_2___/ N° DU DOSSIER CLIENT : /_____152F_____/ FEUILLE N° : /_____/ TRAITEMENT : -Tagamet 800 : 1 comprimé le soir -Mucal : 1 sachet 3 fois par jour -Librax : 1 comprimé 3 fois par jour -Clamoxyl 500 : 2 gélules 2 fois par jour					
Date/heure	Diagnostic infirmier/problèmes identifiés	Objectifs de soins	Interventions	Date/Heure	Résultats de l'évaluation	Nom Prénoms et émargement de l'intervenant
03/03/2020 07h45	Douleurs épigastriques et stress relié à l'UGD se manifestant par les troubles du sommeil	Retrouver son rythme normal de sommeil (7H/jr) au bout de 24 heures	Soins relationnels et éducationnels : - Informer la cliente sur l'origine des douleurs ; -Rassurer la cliente afin de diminuer le stress ; -Conseiller à la cliente de suivre son traitement, de respecter les doses et les horaires de prises des médicaments Soins de surveillance : -Surveiller régulièrement les constantes	04/03/2020 08H	Sommeil retrouvé par la cliente (environ 7h)	Loukou Théophile

	Risque de troubles digestifs liés au Clamoxyl	CT : Reconnaître les signes de dangers liés au traitement MLT : Eviter les dangers liés au traitement	Enseigner à la cliente les effets secondaires indésirables des médicaments et lui demander de signaler en cas de survenue.		Feed-back positif	
	Non-respect du régime probablement dû au manque de connaissance et/ou de volonté	Respecter son régime thérapeutique	Informar la cliente sur l'importance du régime et les conséquences du non-respect de ce régime		Respect des horaires de prise des médicaments	
	Incapacité d'assurer son rôle social dû à l'hospitalisation se manifestant par l'anxiété	CT : Dissiper son anxiété le plus tôt possible. MLT : Retrouver le plus tôt possible son autonomie	- Rassurer la cliente en établissant un climat de confiance ; - Informer davantage la cliente sur sa maladie, on traitement et les contraintes liées à son état ; - Renforcer les attitudes positives, la valoriser ; - Faciliter l'accompagnement par la visite des personnes qui lui sont chères ; - Favoriser la sortie si possible		Anxiété dissipée	

ETUDE DE CAS N°2 TRAVAUX DIRIGES**RECUEIL DES DONNEES**

Vous êtes de garde en suites de couches au service de gynéco-obstétrique du CHU de Cocody. Vous avez à charge Mme Koukougnon Cécila en grossesse de 38 semaines. La cliente est âgée de 36 ans, mariée, commerçante. L'interrogatoire et la consultation du carnet ont révélé que Mme Koukougnon est à son IIème geste et a perdu son premier enfant lors de l'accouchement.

L'examen physique relève des œdèmes généralisés, un utérus hypertonique, des bruits du cœur fœtal(BDCF) très faibles avec une pâleur des conjonctives. Par ailleurs, une prise de poids de plus de 10 kg et une albuminurie sont constatées chez la cliente.

La TA prise ce jour est de 16/10 et le taux d'hémoglobine est de 7g/l.

Le traitement prescrit est le suivant :

Aldomet 250 mg : 2cp matin et soir

Valium 5mg : 1cp matin et soir

Repos strict au lit en décubitus latéral gauche

Régime hygièno diététique équilibré et hyposodé

Hospitalisation

1-Besoins fondamentaux :**1-Respirer**

- Rythme respiratoire 30mvts/mn
- Bruits du cœur fœtal absents

2- Manger et boire

- Vomit lorsqu'elle ingurgite des aliments
- Régime hygièno diététique équilibré et hyposodé

3- Eliminer les déchets biologiques

- Elimine correctement les fèces- œdèmes généralisés

4-Se mouvoir et se maintenir en position convenable

- Enceinte de 38 semaines
- Recherche une position antalgique à cause des douleurs
- Œdèmes généralisés
- BDCF très faibles

- Utérus hypertonique
- Présentation céphalique mobile

5-Dormir et se reposer

- Dort 08 heures par jour habituellement
- Sommeil troublé ce jour à cause des douleurs
- Est obnubilée

6-Se vêtir et se dévêtir

- Couverte partiellement d'un morceau de pagne

7-Maintenir la température du corps dans les limites normales

-T° 37°C

8- Etre propre soigné et protéger ses téguments et phanères

- Drap pas propre et légèrement mouillé par les urines - Ongles non taillées
- Peau humide

9- Eviter le danger

- Elle est anxieuse parce qu'elle craint de perdre de nouveau son enfant
- Utérus hypertonique
- conjonctives pâles

10- Communiquer avec ses semblables

- Organes des sens normaux
- Voix audible, parle peu, mais répond néanmoins aux questions
- Repli sur soi quelques fois
- N'approuve pas la présence de sa belle mère

11- Agir selon ses croyances et ses valeurs

- Croit en Dieu, est de religion chrétienne et prie tous les jours

12- s'occuper en vue de se réaliser

- Pense beaucoup à sa marchandise laissée aux soins de sa nièce au marché
- S'interroge souvent sur l'issue de sa maladie et la durée de l'hospitalisation

13- Se récréer

- Sa distraction favorite est la télévision

14- Apprendre

- Niveau scolaire : primaire

2-Analyse e interprétation des données

2-1-Classification des données

- Analyse des données

<i>Données d'indépendance</i>	<i>Données de dépendance</i>
• Identité de la cliente (sexe féminin, 36 ans, mariée, commerçante) • Elimine correctement • Présentation céphalique • Habituellement dort 8 heures par jour • Organes des sens normaux • Réponds aux questions • Croit en Dieu, chrétienne • Prie tous les jours • Distraction : télévision • Niveau d'instruction : primaire	• Gestose • Hospitalisée • Rythme respiratoire : 30 mvts/mn • BD CF très faibles • Conjonctives pâles • Vomissements • Recherche de position antalgique à cause des douleurs • TA : 15/10 • Œdèmes généralisés • Utérus hypertonique • Troubles du sommeil à cause des douleurs • Obnubilée • Couverte partiellement d'un morceau de pagne • Draps pas propre et légèrement mouillés • Peau humide • Anxiété • Craint de perdre de nouveau son enfant • Repli sur soi • N'approuve pas la présence de sa belle mère • Aldomet • Valium

- Détermination des problèmes de dépendance et des sources de difficultés

<i>Problèmes de dépendance</i>	<i>Source (s) de difficultés</i>
• Troubles respiratoires	• Anémie
• BDC très faibles (possibilité de mort in utéro) • Œdèmes généralisés • Utérus hypertonique • HTA • Vomissements • Obnubilation (trouble de la conscience) • Troubles du sommeil • Douleurs	• Gestose
• Peau humide (risque d'atteinte de l'intégrité de la peau)	• Manque d'hygiène
• Anxiété (risque de dépression)	• Crainte de perdre son enfant
• Perturbation du rôle social	• hospitalisation
• Manifestation de rejet	• Présence de la belle mère
• Possibilité de manifestation d'effets secondaires indésirables	• Aldomet • Valium
• Perturbation de l'intimité	• Aspect vestimentaire

2-3-Diagnostics infirmiers

En rapport avec la maladie :

- Troubles respiratoires reliés à l'anémie
- Possibilité de mort in utéro due à la gestose
- Désordre hémodynamique à cause de la gestose

En rapport avec son traitement

- Possibilité de manifestations d'effets indésirables dus à l'administration de l'Aldomet et du Valium.

En rapport avec sa personne :

- Risque potentiel de dépression dû à la crainte de perdre son enfant se manifestant par l'anxiété
- Perturbation du rôle social reliée à l'hospitalisation
- Manifestation de rejet causée par la présence de la belle-mère se manifestant par le repli sur soi
- Risque d'atteinte de l'intégrité de la peau relié au manque d'hygiène
- Perturbation de l'intimité reliée à son aspect vestimentaire

Besoins fondamentaux non satisfaits :

Il ressort respectivement de ces diagnostics infirmiers les besoins fondamentaux non satisfaits suivants :

- Respirer
- Eviter les dangers
- Se mouvoir et se maintenir en position convenable
- Dormir et se reposer
- Etre propre soigné et protéger ses téguments
- Communiquer avec ses semblables
- S'occuper en vue de se réaliser
- Se vêtir et se dévêtir

PLAN DE SOINS (Source OOAS)

LOGO
DE LA
STRUC
TURE

NOM : KoukougnonPRENOM : Cécilia

SEXE : /__Féminin___/ AGE : /__36ans_/ SITUATION MATRIMONIALE : marié PROVENANCE

SERVICE : Hospitalisée au CHU pour gestose sur une grossesse de 38 semaines

N°CH : /_____/ N° LIT : /_____/N° DU DOSSIER CLIENT : /_____/ FEUILLE N° :
/_____/

TRAITEMENT :

Aldomet 250 mg : 2cp matin et soir

Valium 5mg : 1cp matin et soir

Repos strict au lit en décubitus latéral gauche

Régime hygiéno-diététique équilibré et hyposodé

Date/Heure	Diagnostic infirmier/problèmes identifiés	Objectifs de soins	Interventions	Date/Heure	Résultats de l'évaluation	Nom Prénoms et émargement de l'intervenant
	Troubles du rythme respiratoire reliés à l'anémie	Retrouver le rythme respiratoire normal (18-19 mvts/mn) au bout de 24h	-Appliquer scrupuleusement le traitement prescrit ; -Apprendre à la cliente les exercices respiratoires -Surveiller les constantes : pouls, TA, respiration.		Rythme respiratoire : 18 mvts/mn	Assi Bernadette : SF

	-Possibilité de mort in utéro due à la gestose -Risque potentiel de dépression dû à la crainte de perdre son enfant se manifestant par l'anxiété -Possibilité de manifestations d'effet indésirables dus à son traitement	CT : -Dissiper son anxiété au bout de 24h MLT : - Accoucher d'un nouveau-né en pleine vitalité - Signaler les effets indésirables des médicaments	-Rassurer la cliente par l'établissement d'une relation d'aide -Redoubler d'ardeur dans la prise en charge ; -Surveiller le traitement et les constantes biologiques de la cliente ; -Prendre régulièrement la TA. -Enseigner à la cliente les effets indésirables des médicaments ainsi que la conduite à tenir.		Observer l'issue du processus	
	-Désordre hémodynamique causé par la gestose	CT : Retrouver au bout de 48h l'équilibre hémodynamique MLT : Adopter des postures convenables durant l'hospitalisation	Poursuivre la prise en charge ;		Assez bon état général de la cliente	
	-Troubles du sommeil causé par les douleurs	Dormir selon son rythme habituel de sommeil	-Soulager les douleurs selon la prescription médicale ; -Faire si nécessaire usage des moyens physiques.		Sommeil retrouvé.	

	Risque d'atteinte à l'intégrité de la peau relié au manque d'hygiène	Eviter l'apparition des escarres tout le long de son hospitalisation.	-Assurer l'hygiène générale de la cliente ; -Faire la prévention des escarres et d'autres complications de décubitus éventuelles		Bonne hygiène générale et pas d'atteinte de l'intégrité de la peau.	
	Manifestation de rejet causée par la présence de la belle-mère se manifestant par le repli sur soi.	Accepter sans restriction son entourage	-Expliquer par le biais de la relation d'aide établie avec la cliente, les conséquences psychologiques et biophysiques de la manifestation de ses sentiments négatifs avec son entourage notamment sa belle-mère ; -Insister sur les avantages d'entretenir la bonne humeur.		Client coopérant	
	Perturbation du rôle social reliée à l'hospitalisation.	CT : S'adapter au mieux possible à sa situation. MLT : Retrouver le plus tôt possible son autonomie	-Favoriser son adaptation à travers la relation d'aide ; -Poursuivre la prise en charge ; -Favoriser si possible la sortie.		Pas d'anxiété	
	Perturbation de l'intimité reliée à son aspect vestimentaire	Recouvrer le plus tôt possible son intimité	-Proposer une tenue de lit ; -Couvrir la cliente entièrement d'un drap propre.		Intimité retrouvée	

ETUDE DE CAS N°3 :

Profil d'un client à partir du cadre de référence de Virginia Henderson

1-Collecte de données

- **Renseignements généraux**

Nom et Prénoms : Doué Simplicie

Age : 5 ans

Sexe : Masculin

Situation matrimoniale : Célibataire

Profession : Ecolier

Diagnostic médical : Paludisme grave

Régime : Hospitalisé

Traitement :

- Quinimax 0,40
- Bencozyme 1 ampoule dans 250 ml de Ringer, en perfusion, 2 fois par jour pendant 3 jours
- Novalgin 1 ampoule en IVD

Besoins fondamentaux

1-Respirer

- Polypnée

2-Boire et manger

- Adore le pain au chocolat
- Manque d'appétit ce jour

3-Éliminer : A vomit le repas pris au petit déjeuner

4-Se mouvoir et se maintenir en bonne posture

- Changements réguliers de posture à cause des malaises
- Pas d'atteinte de l'intégrité de la peau

5-Dormir et se reposer

- Troubles du sommeil

6-Se vêtir et se dévêtir

- Vêtu d'un pyjama

7-Maintenir la température dans les limites de la normale :

- T° 39°C

8-Être propre soigné et protéger ses téguments

- Peau et téguments propres
- Draps propres et biens dressés

9-Éviter les dangers

- Administration de sels de quinine en perfusion

10-Communiquer avec ses semblables

- Répond très peu aux questions
- Intégrité des sens

11-Agir selon ses croyances et ses valeurs

- N'exprime rien de particulier

12-S'occuper en vue de se réaliser

- Ne peut aller à l'école à cause la maladie et l'hospitalisation

13-Se recréer

- Ne peut prendre part à son jeu favori : le football

14-Apprendre

- RAS

2- Analyse et interprétation des données

2-1 Classification des données

Données d'indépendance	Données de dépendance
- Identité du client - Adore le pain au chocolat - Pas d'atteinte de l'intégrité de la peau - Vêtu d'un pyjama - Peau et téguments propres - Draps propres et biens dressés - Répond très peu aux questions - Intégrité des sens - N'exprime rien de particulier - RAS	- Paludisme grave - Traitement : • Quinimax 0,40 • Bencozyme 1 ampoule Dans 250 ml de Ringer, en perfusion, 2 fois par jour pendant 3 jours • Novalgin 1 ampoule en IVD - Hospitalisation - Polypnée - Manque d'appétit ce jour - A vomit le repas pris au petit déjeuner - Changements réguliers de posture à cause des malaises - Troubles du sommeil - Ne peut aller à l'école à cause la maladie et l'hospitalisation - Ne peut prendre part à son jeu favori : le football

2-2 Détermination des problèmes de dépendance et des sources de difficultés

Manifestations de dépendance	Sources de difficultés
- Polypnée - Manque d'appétit - Vomissements - Malaises - Troubles du sommeil - Température 39°C - Possibilité d'anémie	- Paludisme grave
- Possibilités d'effets indésirables (hypoacousie, surdité) - Risque de surcharge hydrique (OAP) - Incapacité d'aller à l'école - Ne peut prendre part à son jeu favori : le football	- Quinine - Perfusion - Maladie, Hospitalisation

2-3 Diagnostics infirmiers

- Possibilité d'anémie due au paludisme se manifestant par la polypnée et les malaises.
- Troubles du sommeil dus à la maladie.
- Difficulté à s'alimenter reliée à la maladie.
- Troubles digestifs à cause de la maladie se manifestant par les vomissements.
- Hyperthermie reliée au paludisme.
- Risque d'effets indésirables (hypoacousie, surdité) relié à l'administration des sels de quinine.
- Risque d'OAP dû à la perfusion
- Perturbation du rôle social à cause de la maladie aggravée par l'hospitalisation.
- Impossibilité de se recréer à cause de la maladie aggravée par l'hospitalisation.

2-4 Classification des diagnostics infirmiers

• Diagnosics infirmiers en rapport avec la maladie :

- Possibilité d'anémie due au paludisme se manifestant par la polypnée et les malaises.
- Troubles du sommeil dus à la maladie.
- Difficulté à s'alimenter reliée à la maladie.
- Troubles digestifs à cause de la maladie se manifestant par les vomissements.
- Hyperthermie reliée au paludisme.

• Diagnosics infirmiers en rapport avec le traitement :

- Risque d'effets indésirables (hypoacousie, surdité) relié à l'administration des sels de quinine.
- Risque d'OAP dû à la perfusion

• Diagnosics infirmiers en rapport avec la personne du client :

- Perturbation du rôle social à cause de la maladie aggravée par l'hospitalisation.

- Impossibilité de se recréer à cause de la maladie aggravée par l'hospitalisation.

Il ressort de ces diagnostics les besoins fondamentaux non satisfaits selon le modèle conceptuel de Virginia Henderson :

- Respirer
- Dormir et se reposer
- Manger et boire
- Éviter les dangers
- Maintenir la T° dans les limites de la normale
- S'occuper en vue de se réaliser
- Se recréer

Ces diagnostics infirmiers et l'identification des besoins non satisfaits terminent l'étape de l'analyse et l'interprétation des données. On passe ensuite aux étapes suivantes à savoir, la planification, l'exécution et l'évaluation de l'intervention, cela à travers un plan.

PLAN DE SOINS

Nom et prénoms : Doué Simplicie

Age : 5 ans Sexe : M

Profession : Ecolier

LOGO DE LA STRUCTURE	NOM : Doué					
	PRENOM : Simplicie					
	SEXE : /___M___/ AGE : /___05 Ans___/ PROVENANCE ...Agboville..... PROFESSION : Ecolier					
	SERVICEPédiatrie.....					
	N°CH : /_1___/ N° LIT : /_3___/					
N° DU DOSSIER CLIENT : /___255D___/ FEUILLE N° : /___/						
DIAGNOSTIC MEDICAL : Paludisme grave						
REGIME : Hospitalisé						
Traitement :						
- Quinimax 0,40						
- Bencozyme 1 ampoule						
Dans 250 ml de Ringer, en perfusion, 2 fois par jour pendant 3 jours						
- Novalgin 1 ampoule en IVD						
Date/Heure	Diagnostic infirmier/problèmes identifiés	Objectifs de soins	Interventions	Date/Heure	Résultats de l'évaluation	Nom Prénoms et émargement de l'intervenant
	Hyperthermie liée au paludisme	Retrouver sa T° normale (37°C) au bout de 12 heures	Soins d'exécution des prescriptions médicales : - Exécuter scrupuleusement le traitement prescrit		T° 37°C	Kouassi Valentin : IDE

			- Si nécessaire utiliser les moyens physiques pour lutter contre la fièvre Soins de surveillance : -Surveiller régulièrement les constantes notamment la T° - Noter les constantes Soins relationnels et éducatifs : - Informer le client sur sa maladie et son traitement ainsi que les attentes de l'équipe soignante.			
	-Risque d'effets indésirables (hypoacousie, surdit�) reli��� l'administration des sels de quinine. -Risque d'OAP d��� la perfusion	CT : -Reconnaitre les effets ind���rables du traitement -Comprendre les pr���cautions �� prendre pendant son traitement MLT : -Eviter les complications	-Enseigner au client et �� sa m���re les effets secondaires des m���dicaments et lui demander d'alerter le m���decin en cas de survenues de ces effets ; -Rassurer le client afin de diminuer le stress ; -Informer la cliente sur l'importance du de l'observance du traitement - Surveiller les r���actions du client face au traitement		-Feedback positif -Bonne observance du traitement -Pas d'effets secondaires ind���sirables signal���s par le client	

	Perturbation du rôle social à cause de la maladie aggravée par l'hospitalisation	-Retrouver le plus tôt possible son autonomie	-Rassurer le client en établissant un climat de confiance ; -Informer davantage le client sur sa maladie, on traitement et les contraintes liées à son état ; - -Proposer des jeux ou la lecture ; -Faciliter l'accompagnement par la visite des personnes qui lui sont chères ; -Favoriser la sortie si possible.		-Pas d'anxiété. -Bonne évolution de l'état général.	
--	--	---	--	--	--	--

EXERCICE

Mme SORO, 31 ans, mariée, mère de deux (02) enfants, commerçante (vendeuse de poisson frais) est hospitalisée pour paludisme avec une température de 39°C et une TA de 12/8.

Ce jour, la cliente affiche un air anxieux. À l'interrogatoire, elle révèle que la veille de son hospitalisation, elle a reçu une commande importante de sa marchandise. Comme traitement prescrit et mise en route pour sa maladie Mme SORO est mise sous sels de quinine en perfusion.

QUESTIONS

1. Déterminez quatre (4) diagnostics de soins dont :
 - deux (2) en rapport avec la maladie (un problème actuel et un problème potentiel)
 - un (1) en rapport avec le traitement
 - un (1) en rapport avec la personne de la cliente
2. Identifiez pour chaque diagnostic de soins, un besoin fondamental prioritaire non satisfait (MC de V. Henderson)
3. Énoncez pour chaque diagnostic de soins (en rapport avec le besoin fondamental non satisfait) un ou des objectifs de soins
4. Proposez un plan de soins pour Mme SORO.

PENSEE CRITIQUE

PENSEE CRITIQUE

Objectif général :

Amener les étudiants(es) à cerner la notion de pensée critique

Objectifs spécifiques :

L'étudiant L2 doit être capable de :

1. Donner une définition de la pensée critique en général et en soins infirmiers
2. Expliquer l'importance de la pensée critique
3. Énumérer tous les éléments clés de la pensée critique
4. Décrire toutes les principales attitudes de l'infirmier(e) à l'application de la pensée critique

I. DÉFINITIONS

La pensée critique est la capacité d'analyser, d'évaluer et de structurer l'information de manière objective, rigoureuse et rationnelle pour distinguer les faits des opinions. Elle permet de remettre en question les préjugés, d'identifier les biais cognitifs et prendre des décisions éclairées basées sur des preuves.

- Composantes : Elle associe une attitude intellectuelle (esprit critique, scepticisme, sain) à des compétences pratiques (analyse, raisonnement logique)
- Processus : Elle implique de poser des questions, vérifier la fiabilité des sources, examiner divers points de vue, et éviter les raisonnements fallacieux.

La pensée critique en soins infirmiers est une compétence essentielle qui permet de penser par soi-même, analyser la situation d'un patient, prendre des décisions cliniques sûres et appropriées et améliorer en continu la qualité des soins.

II. GÉNÉRALITÉS

Qu'est-ce qu'une pensée critique en soins infirmiers ?

La pensée critique en soins infirmiers est un processus de réflexion systématique et logique qui permet à l'infirmier(e) de :

- Collecter et analyser les informations pertinentes du patient,
- Évaluer les preuves et les données cliniques,
- Formuler un jugement éclairé,
- Prendre des décisions appropriées,
- Réfléchir sur les résultats de ces décisions pour s'améliorer

Concrètement, il ne s'agit pas d'appliquer des recettes apprises par cœur, mais d'adapter les interventions à la situation unique de chaque patient, en se basant sur des données objectives plutôt que sur des impressions ou des habitudes.

III. IMPORTANCE DE LA PENSÉE CRITIQUE

Pourquoi c'est essentiel en soins infirmiers ?

La pensée critique permet à l'infirmier (e) de :

1. Assurer la sécurité des patients :

Détecter rapidement les signes de détérioration, anticiper les complications et agir de façon appropriée avant qu'un problème ne s'aggrave.

2. Prendre des décisions basées sur des preuves

Analyser des éléments cliniques, des résultats, des résultats de tests, ou des données de recherche pour choisir l'intervention la plus valide.

3. Fournir des soins personnalisés

Les besoins du patient ne sont pas toujours évidents au premier regard : la pensée critique permet d'identifier les problèmes sous-jacents et les priorités.

4. Travailler efficacement en équipe

Communiquer clairement les observations et décisions, et justifier ses choix, et collaborer avec d'autres professionnels de santé.

IV. ÉLÉMENTS CLÉS DE LA PENSÉE CRITIQUE

Les infirmiers (es) doivent développer plusieurs compétences :

- Analyse et évaluation des données (signes vitaux, plaintes, tests)
- Différenciation entre faits et opinions
- Évaluation de la crédibilité des sources d'information
- Justification des conclusions cliniques
- Capacité à tirer des conclusions utiles pour l'action
- Réflexion sur sa propre pratique et les biais.

V. APPLICATION DE LA PENSÉE CRITIQUE

Comment est-elle appliquée au quotidien ?

1 Suivi de la démarche de soins infirmiers

Un cadre structuré qui aide à penser de manière logique : Collecte de données, Diagnostic, Planification, Implémentation, Évaluation.

2 Réflexion critique

Après chaque situation ou intervention, réfléchir à ce qui a bien fonctionné, ce qui peut être amélioré et pourquoi certaines décisions ont été prises.

3- Apprentissage continu

Se tenir à jour avec des preuves plus récentes, participer à des formations et simuler des cas cliniques.

4- communication et collaboration

Échanger avec des pairs, mentors, médecins et autres professionnels pour valider et enrichir les décisions.

ETUDE DE CAS 1

Vous êtes infirmier(e) dans un service d'urgence. Un patient arrive avec des symptômes pénibles tels que des douleurs thoraciques, des palpitations et des vertiges.

En exerçant votre esprit critique, que feriez-vous ?

Réponse :

- Faire rapidement le lien entre les symptômes et la possibilité d'un accident cardiaque
- Informer le médecin

Ce qui garantit une prise en charge et peut sauver la vie du patient.

ETUDE DE CAS 2 (Travaux de groupe)

Vous êtes infirmier(e) dans un service de médecine hospitalisation. Le patient Zorro y est hospitalisé et mis sous traitement pour fièvre typhoïde à la phase d'état. Pendant la surveillance du patient, vous vous proposez d'exercer votre esprit critique. Qu'allez-vous faire immédiatement et quelle sera la suite de votre action ?

REFERENCES

- 1-A.M.I.E.C :** Les infirmières construisent leur avenir
Edition le centurion, Lyon 1986
- 2-AMAR B ; J-P. GUEGUEN :** Concept et théories, démarche de soins
Nouvelle Edition, MASSON
- 3-BIZIER, Nicole:** Un modèle conceptuel en soins infirmiers : de la pensée
au geste 3^{ème} édition .Editions DECARIE Montréal 1992
- 4-COTINAUD, Olivier :** Eléments de la psychologie pour l'infirmière
Edition le centurion, Paris 1967
- 5-CRESPINET Annie et coll: Guide** d'observation des 14 besoins de l'être
humain - Edition De Boeck Université, Namur 1989
- 6-EVELYNE Adams :** Etre infirmière
- 7-HENDERSON, Virginia :** Principes fondamentaux des soins infirmiers
Editions Masson C.I.I, Genève 1977
- 8-HENDERSON, Virginia :** Besoins fondamentaux de la personne
Editions Masson C.I.I, Genève
- 9-HENDERSON, Virginia :** La nature des soins infirmiers
Edition, le Renouveau Pédagogique ERPI 1994
- 10-KOZIER et ERB :** Soins infirmiers/conception globale,
Edition, le Renouveau Pédagogique Montréal 1985
- 11-POLLETTTI Rosette :** Soins infirmiers / Théories et concepts,
Edition du Centurion, 1978
- 12-RIOPPELLE –GRONDIN –PHANEUF :** Soins infirmiers : Démarche
Scientifique Editions McGraw-Hill, Québec 1885
- 13-RIOPPELLE –GRONDIN –PHANEUF :** Soins infirmiers : Un modèle centré
sur les besoins de la personne
Editions McGraw-Hill, Québec 1884
- 14-L'UNIVERSAL MEDICAL :** Approche globale des soins infirmiers,
Edition des presse de LUTECE ; TOME 3 1987
- 15- NOUMSSI ET COLL :** Cours de soins infirmiers en médecine et en chirurgie
Université de Yaoundé (Cameroun)